



ถอดรหัสการพยาบาล ศัลยกรรมทางเดินอาหาร

เข้าใจ Stapler และการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
ลดน้ำหนักแบบ Step-by-Step

นำเสนอโดย: Watanyuta Wianchai | ฝ่ายการพยาบาลผ่าตัด (Perioperative Nursing Division)

ทำไมเราถึงต้องใช้ Surgical Stapler?

อดีต



การเย็บด้วยมือ (Hand Sutured)

ปัญหาใหญ่ของการเย็บกระเพาะและลำไส้ด้วยมือ คือความเสี่ยงในการเกิด "รอยรั่ว" (Leakage) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะแทรกซ้อน

ปัจจุบัน



การใช้เครื่องมือเย็บ (Surgical Stapler)

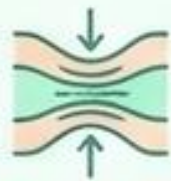


- **รวดเร็วกว่า (Significantly Quicker):**
ลดระยะเวลาการผ่าตัดและเวลาที่ผู้ป่วยต้องดมยาสลบ



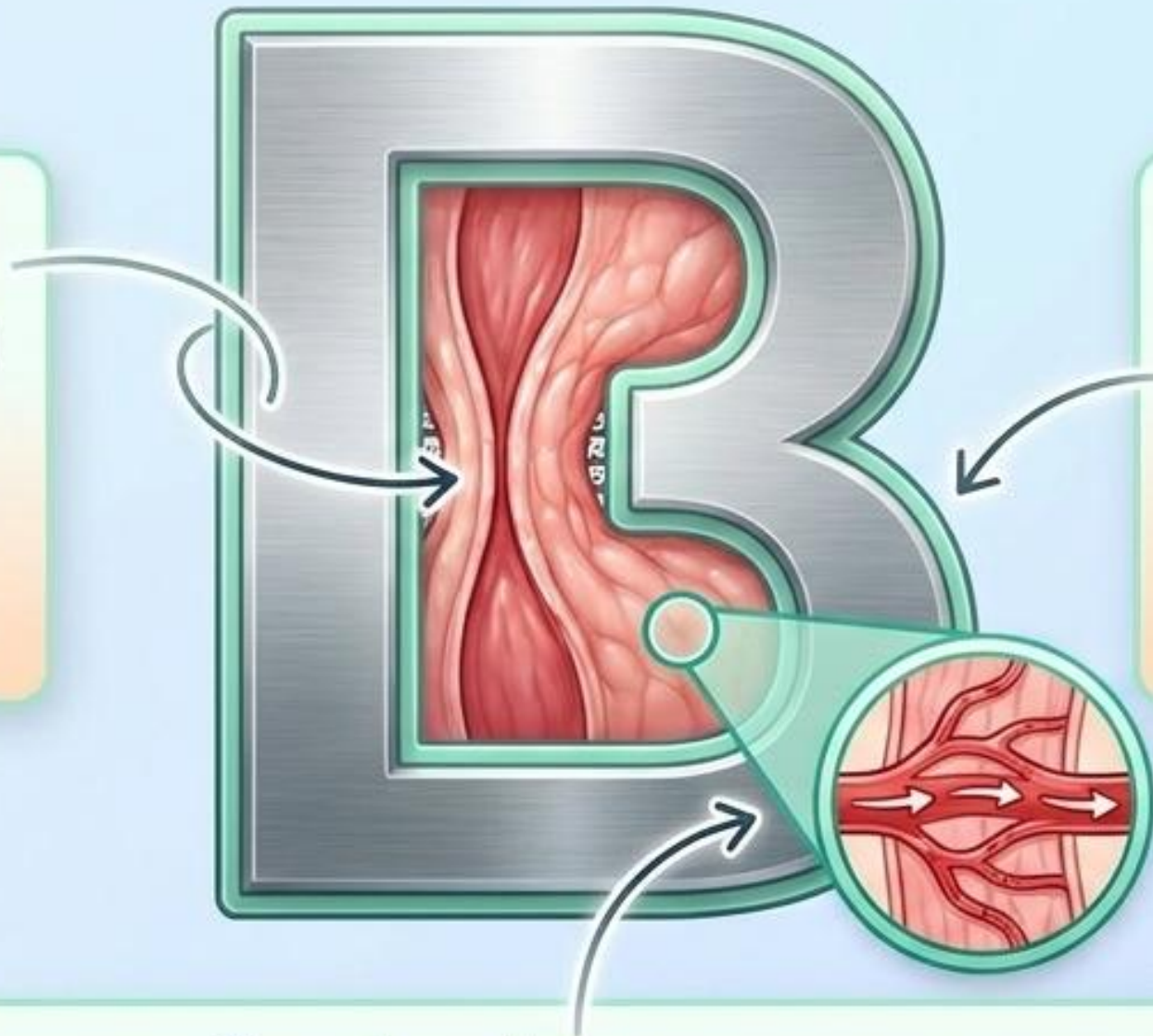
- **ปลอดภัยกว่า (Security against leaks):**
สร้างรอยเย็บที่สม่ำเสมอ ลดโอกาสการรั่วซึมของของเหลวหรือเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความลับของหลักการ “ตัวบี” (B-Shape Principle)



บีบอัดอย่างพอดี (Tissue Compression)

- เนื้อเยื่อถูกประกบเข้าหากันแน่นพอที่จะสร้างผนังใหม่ แต่ไม่แน่นจนเกินไป



ป้องกันการรั่วซึม (Avoiding Leakage)

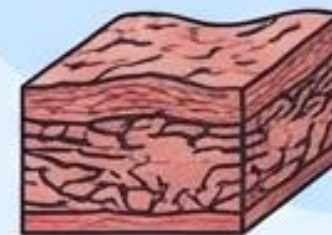
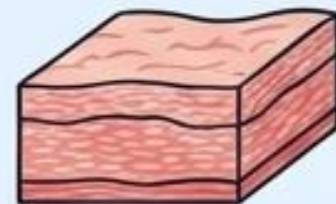
- สร้างแนวป้องกันที่แข็งแรง ป้องกันการเกิดรอยรั่วและแผลทะลุ (Fistula formation)



รักษาการไหลเวียนเลือด (Preserve Vascularization)

- ช่องว่างของตัว “B” ช่วยให้เส้นเลือดฝอยยังส่งเลือดไปเลี้ยงแผลได้ ทำให้เนื้อเยื่อสมานตัวและไม่ตาย

การเลือกสีตลับลวด (Cartridge Colors) ให้เหมาะกับความหนาเนื้อเยื่อ



ขาว (White)

ฟ้า/น้ำเงิน (Blue)

เขียว (Green)

ดำ (Black)

บางมาก
(Vascular)

ความหนาปกติ
(Standard)

หนา
(Thick)

หนาเป็นพิเศษ
(Extra Thick)

เส้นเลือด

กระเพาะ/ลำไส้ทั่วไป

กระเพาะส่วนที่หนา

เนื้อเยื่อที่หนามากผิดปกติ

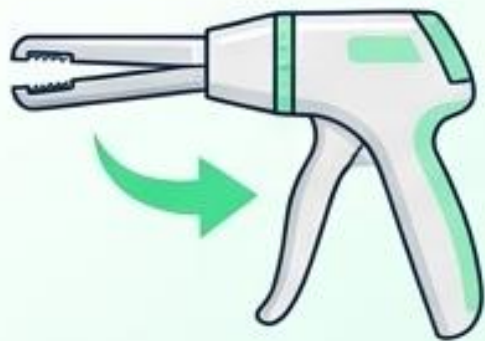


***ข้อควรระวัง:** ประเมินแรงต้านขณะยิงเสมอ

การเลือกความสูงลวด (Staple height) ให้ตรงกับความหนาเนื้อเยื่อคือหัวใจสำคัญ

Safety First! เช็คลิสต์ 4 ข้อ ก่อนยิง Stapler

1. เช็คความพร้อม (Examine & Assemble)



ตรวจสอบเครื่องมือว่า
ประกอบถูกต้อง ล็อกสนิท
และสะอาดพร้อมใช้งาน

2. ใส่ตลับลวด (Seat Cartridges)



ตลับลวด (Cartridge)
ต้องใส่ลงล็อกพอดี
ไม่มีรอยเพยง

3. เคลียร์พื้นที่ (Clear Obstructions)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
สิ่งกีดขวางบริเวณที่จะตัด
เช่น คลิปเหล็ก (Clips)
หรือสาย Bougie

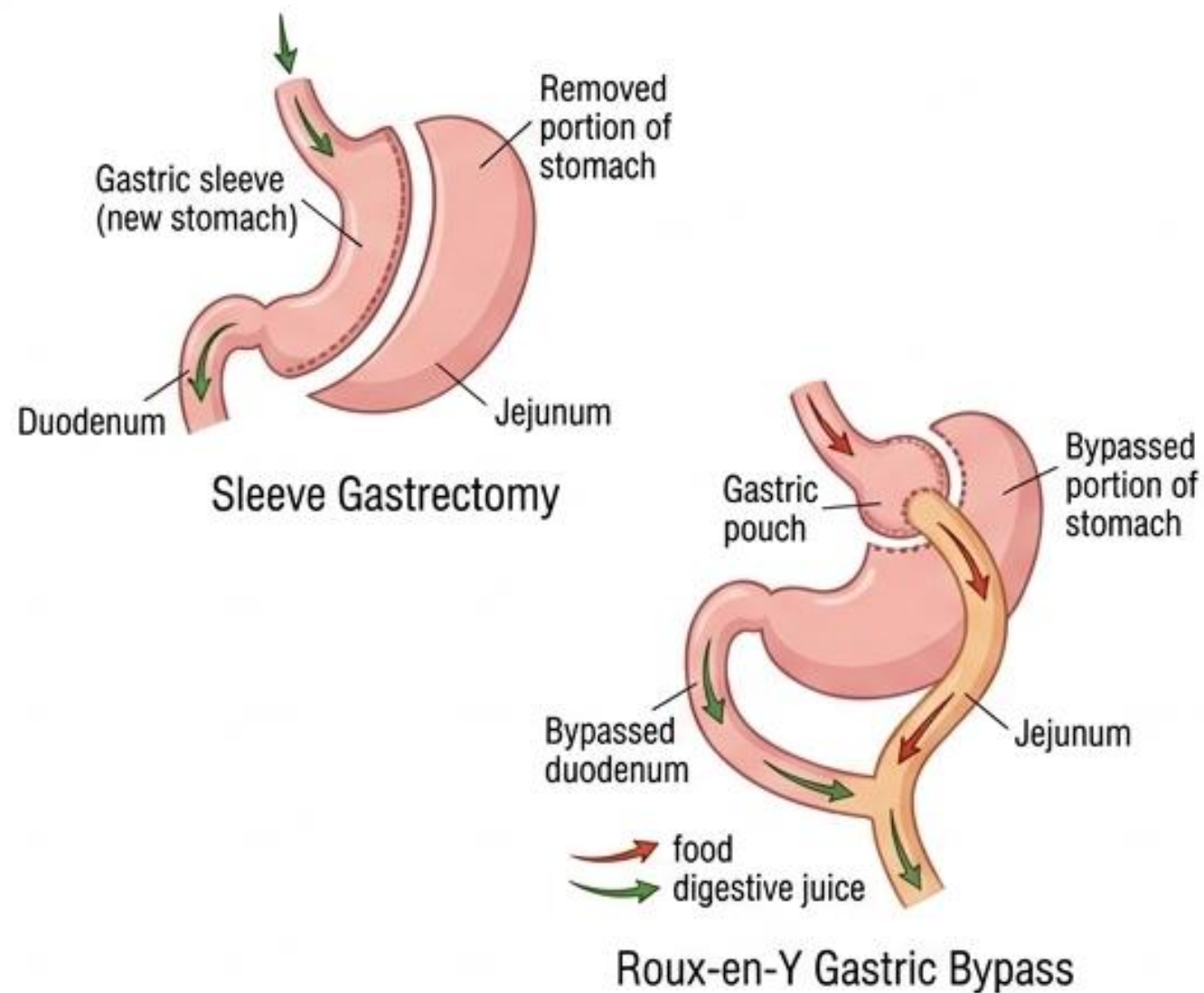
4. กดแรงบีบ (Firing Forces)



สังเกตแรงต้านขณะบีบ
หากรู้สึกฝืดหรือตึงเกินไป
ให้หยุดและประเมินความ
หนาเนื้อเยื่อใหม่

จากเครื่องมือสู่การดูแลผู้ป่วย: กรณีศึกษาผ่าตัดลดน้ำหนัก

การผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก (Bariatric Surgery) เป็นหัตถการที่มีการใช้ Stapler ในการ ในการตัดต่อทางเดินอาหารอย่างซับซ้อน



เกณฑ์ผู้ป่วยผ่าตัด (NIH Guideline):

-  - BMI > 40
-  - BMI > 35 พร้อมมีโรคร่วม (Co-morbidities)
-  - มีประวัติอ้วนมานาน และล้มเหลวจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีไม่ผ่าตัด
-  - ผู้ป่วยพร้อมให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Pre-op Assessment)



ประวัติสุขภาพ

ซักประวัติส่วนตัว, ประวัติ
ครอบครัว (GI disorders,
โรคมะเร็ง), และโรคร่วมต่างๆ



ประวัติโภชนาการ

เจาะลึกพฤติกรรมการกิน,
ภาวะเบื่ออาหาร (Anorexia),
หรืออาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)



การขับถ่ายและน้ำหนัก

การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว,
อาการท้องผูก/ท้องเสีย,
และสีของอุจจาระ

ประเมินความปวด (PQRST)

P: ปัจจัยกระตุ้น (Precipitating)

Q: ลักษณะความปวด (Quality)

R: ตำแหน่ง (Region)

S: ระดับความปวด 0-10 (Severity)

T: ระยะเวลาและความถี่ (Timing)

Day 0

Post-op Day 0: วันแรกหลังผ่าตัด

จุดเริ่มต้นการฟื้นตัว

โภชนาการและยา



งดน้ำและอาหาร (NPO)
ให้สารน้ำ Acetar 1000 ml IV
(120ml/h)
ยา: Morphine 2mg IV (prn q 2
hr), Ondansetron (แก้คลื่นไส้),
Omeprazole, Ceftriaxone,
Metronidazole

การเฝ้าระวัง (Monitoring)



Record V/S, O2 Sat, Urine
Output ทุก 2 ชม. (Notify ถ้า BP
<90/60, PR >120, O2 <90%)
เจาะน้ำตาล POCT ทุก 6 ชม.
(Keep 80-200 mg% - ให้ RI
ถ้าเกิน 200)

การป้องกัน (Prevention)



ระบบหายใจ: O2 cannula 3 LPM
(ถ้ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ / OSA
ให้ใช้เครื่อง CPAP ทุกครั้งที่หลับ)
ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน (DVT):
ใส่เครื่องบีบนิ้ว (Sequential
compression) ถอดได้เมื่อลงเดิน +
ฉีด Heparin 5000 unit SC (เริ่มที่ 6
ชม. หลังผ่าตัด หากไม่มี Bleeding)

Day 1

Post-op Day 1: ทยับตัวไว ฟ้นฟูเร็ว (Early Recovery)



เริ่มทยับตัว: กระตุ้นให้ผู้ป่วยลุกเดินจากเตียง (Early Ambulation) ให้เร็วที่สุด



ปรับโภชนาการ: เริ่มจิบน้ำใส (Clear liquid diet - No sugar, Low fat, High protein) 600-800 kcal/day



การปลดสายยาง: Wean off O2 (ถ้า O2 sat >90%) และ ปลดสายสวนปัสสาวะ (D/C Foley catheter) ติดตามการปัสสาวะเอง



การเฝ้าระวังต่อ: เจาะ POCT q 6 hr (ในผู้ป่วยเบาหวาน), แจ้งทีมโภชนาการเข้าประเมิน



ทริคสำคัญการพยาบาล: "ยาทุกชนิดต้องบดให้ละเอียด และผสมน้ำก่อนรับประทานทุกครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัด" เพื่อป้องกันการอุดตันของกระเพาะอาหารที่ถูกเย็บใหม่

**Day 2 /
Discharge**

Post-op Day 2: เตรียมตัวกลับบ้านด้วย 'กฎ 5 ข้อ'

สถานะ: รับประทานอาหารเหลว (Liquid diet) ต่อเนื่องไปอีก 2 สัปดาห์

กฎ 5 ข้อ หลังผ่าตัดกระเพาะ:



1. **งดของหวานและของเหลวที่มีน้ำตาล:**
ป้องกันภาวะ Dumping Syndrome



2. **เคี้ยวช้าๆ:**
ให้ละเอียดที่สุดก่อนกลืน



3. **กินแค่ 1 ถ้วย:**

4. **ห้ามกักตุนอาหาร:**

ฝึกพฤติกรรมการกินใหม่ ไม่กินเพื่อ



5. **จดบันทึกทุกอย่างที่กิน:**

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักษาน้ำหนักในระยะยาว

สรุปแผนการดูแลผู้ป่วย Bariatric (Clinical Pathway Day 0-2)

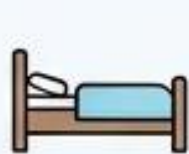
Day 0 (พักฟื้น)

โภชนาการ (Diet)



NPO + IV Fluid

กิจกรรม (Activity/Tubes)



Bed rest, ใส่เครื่องบีบนวดขา, O2/CPAP

การเฝ้าระวัง/ยา (Care)



Monitor V/S, Heparin (หลัง 6 ชม.), POCT

Day 1 (ขยับตัว)

โภชนาการ (Diet)



จิบน้ำใส (Clear liquid)

กิจกรรม (Activity/Tubes)



กระตุ้นลุกเดิน
(Ambulation),
Off Foley, Off O2



การเฝ้าระวัง/ยา (Care)



บดยาทุกชนิด



ปรึกษาโภชนาการ

Day 2 (เตรียมกลับบ้าน)

โภชนาการ (Diet)



อาหารเหลว
(Liquid diet - ต่ออีก 2 สัปดาห์)

กิจกรรม (Activity/Tubes)



เตรียมตัว D/C Home

การเฝ้าระวัง/ยา (Care)



สอน “กฎ 5 ข้อ”,
การประเมินตัวเองที่บ้าน

การวางแผนจำหน่าย: พื้นตัวไวยด้วยแนวทาง ERAS



ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) = โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเพื่อ
ตัวงยับแฉการบื้อให้พื้นตัวไวย สดภาวะแทรกซ้อน และกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด



Start Early: เริ่มต้นวางแผนการจำหน่าย
ตั้งแต่วันแรกที่รับผู้ป่วยแอดมิด
(Discharge Planning Starts on Day 1)



Multidisciplinary Team:
การทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
(แพทย์, พยาบาล, นักโภชนาการ,
กายภาพบำบัด)

- สอนเรื่องโภชนาการอย่างละเอียด (Nutritional teaching)
- การดูแลแผลผ่าตัด (Wound care)
- การประเมินความพร้อมในการทำกิจวัตรประจำวัน (Functional needs)



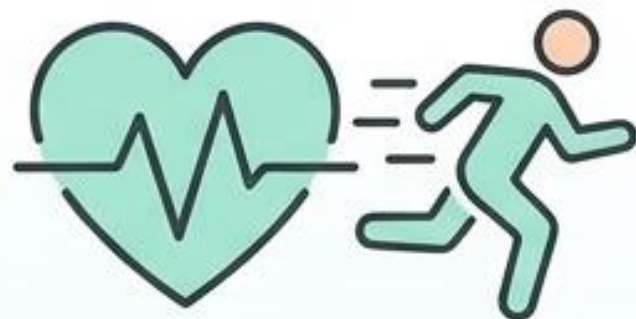
**HOSPITAL
DISCHARGE
PLAN**

บทสรุป (Key Takeaways)



Tool Mastery (เข้าใจเครื่องมือ)

เลือกใช้ตลับลวด (Cartridge)
ให้ถูกสีตรงความหนาของเนื้อเยื่อ
และทำ Safety Checklist เสมอ
เพื่อป้องกันรอยร้าวและเพิ่ม
ความปลอดภัยสูงสุด



Active Pathway (ดูแลตามสเตป)

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดใน Day 0,
กระตุ้นการลุกเดิน (Early
ambulation) ใน Day 1, และที่สำคัญ
**"ยาทุกชนิดต้อง बदละเอียดย
ตลอด 3 เดือนแรก"**



ERAS & Teamwork (วางแผนฟื้นฟู)

เริ่มวางแผนกลับบ้านตั้งแต่แรก
ที่รับใหม่ สอนผู้ป่วยด้วย **"กฎ 5 ข้อ"**
และทำงานประสานทีมสหสาขา
เพื่อคุณภาพชีวิตระยะยาว
ที่ดีของผู้ป่วย